

Prendersi cura di persone autistiche di ogni età nel vostro ambulatorio

La guida cumulativa per medici di famiglia e professionisti sanitari — lungo l'intero arco di vita autistico, dall'età prescolare all'età avanzata ad alto supporto. Una scheda di riferimento estesa; abbinatela alle guide rapide per singola età.

L'idea chiave

L'autismo, attraverso il **monotropismo**, significa che l'attenzione si chiude in pochi „tunnel” profondi e intensi. Dentro un tunnel, il focus è vivido; fuori, le cose si registrano a malapena — a volte inclusi dolore o qualcuno che parla; e cambiare tunnel costa energia vera. Questa singola differenza spiega le reazioni sensoriali, gli interessi forti, il bisogno di routine e i meltdown/shutdown che portano le persone autistiche alla vostra porta. **Lavorate con il tunnel, non contro.** L'ambulatorio è uno degli ambienti più difficili in cui entra una persona monotropica — piccoli adattamenti prevedibili cambiano gli esiti.

Cosa aiuta a ogni età

- **Inviare un modulo pre-visita per gli adattamenti** (l'*AHAT* dell'AASPIRE, autismandhealth.org) e leggetelo prima che arrivino.
- **Riducete il carico sensoriale:** luce più soffusa, stanza più quiete, meno bip, niente profumi forti; offrite la prima/ultima fascia (la più quiete).
- **Comunicare alla lettera e per iscritto:** spiegate ogni passaggio *prima* di farlo; dite ciò che intendete; offrite un riepilogo scritto e follow-up scritto/online; permettete lunghi silenzi per l'elaborazione.
- **Permettete un accompagnatore di fiducia e un kit sensoriale** (cuffie, occhiali da sole, oggetto fidget/d'interesse); lasciate che la persona guardi altrove, faccia stimming o usi la CAA.
- **Co-create una routine di cura prevedibile:** stessa stanza, stessa sequenza, adattamenti efficaci salvati nella cartella in modo che siano automatici la volta dopo.
- **Trattate la persona come l'esperto della propria esperienza** — l'autovalutazione è prova primaria.

Cosa evitare a ogni età

- Forzare il contatto visivo, procedure a sorpresa, contenzione o frasi del „sii coraggioso!”.
- Interpretare pochi minuti calmi e mascherati come „sta bene”, o uno shutdown come rifiuto di collaborare.
- Equiparare il „non lamentarsi” al „non soffrire” (le differenze di interocezione fanno sì che dolore e sintomi possano essere ritardati o atipici).

Età prescolare (2-5)

Attenzione rallentata „appiccicosa”, interessi focalizzati intensi, differenze sensoriali e gioco atipico sono segnali precoci — **rinviate presto** alla valutazione. Inseritevi nell’interesse del bambino prima di visitarlo; accogliete un oggetto di conforto. Prendete sul serio la preoccupazione dei genitori.

Scuola primaria (6-11)

„A posto a scuola, crollo a casa/ambulatorio” è il classico pattern mascherato. Chiedete del **carico scolastico e del recupero**, non solo dei sintomi. State attenti al burnout/„regressione” sotto sovraccarico — riducete le richieste, non spingete. Cercate le co-occorrenze comuni (ansia, ADHD/AuDHD, sonno, gastrointestinale).

Adolescenza (12-18)

L’età di picco per **ansia, depressione e burnout**; molti sono identificati per la prima volta in crisi. **Cercate la suicidalità direttamente**. Distinguate il burnout autistico (richiede richieste ridotte + rimozione della maschera) dalla depressione. Validate gli interessi come identità e recupero. Pianificate presto la transizione ai servizi adulti.

Università / college (18-25)

Una transizione enorme; molti sbattono contro un muro al 1°-2° anno. Offrite opzioni a **prima lo scritto**. Riconoscete il burnout rispetto al comune stress studentesco. Una temporanea riduzione del carico accademico è un passo di recupero legittimo, non un fallimento.

Adulto che lavora

Nell’ambiente giusto: punti di forza profondi. In quello sbagliato: deplezione cronica, masking, **burnout** (distinto dal burnout lavorativo e dalla depressione). Chiedete del carico lavorativo; **iniziate i farmaci a basso dosaggio e titolate lentamente** (risposte atipiche sono comuni). Segnalate gli adattamenti sul posto di lavoro.

Genitore

Il genitorato è incessantemente ad alto canale — alto rischio di **burnout**, e spesso ignorano la propria salute (interocezione + iper-focus sul bambino). Rendete la cura perinatale prevedibile e calma; cercate proattivamente i bisogni del genitore; li sottovaluteranno.

Adulto più anziano (60+)

Il gruppo meno studiato e con i peggiori esiti; molti mai identificati. State attenti a decenni di burnout accumulato fraintesi come „invecchiamento”. **Distinguate con cura la differenza autistica dalla demenza** — le evidenze sono scarse; valutate, non presupponete. Proteggete interessi e routine lifelong; tenete conto del calo uditivo/visivo che si somma alle differenze sensoriali.

Cura ad alto supporto / residenziale (qualsiasi età)

Trattate il nuovo malessere come **dolore o sovraccarico finché non è dimostrato il contrario** (stitichezza, dolore dentale, infezioni, attrezzature mal calibrate sono cause nascoste comuni). Usate il decision-making supportato; conservate routine, oggetti e interessi; avere un piano calmo per meltdown/shutdown (riducete gli stimoli, assicurate la sicurezza, nessuna contenzione).

Red flag valide lungo tutto l'arco di vita

Il burnout autistico non è depressione — esaurimento cronico, perdita di competenze e ridotta tolleranza agli stimoli; trattarlo come depressione o „sforzati di più” lo approfondisce e alza il rischio di suicidio. **Il masking in ambulatorio è costoso** — non lasciate che 15 minuti composti sovrastino l'anamnesi. **„Non si lamenta” ≠ „non soffre”** — chiedete proattivamente di dolore e sintomi. **Il nuovo malessere in una persona ad alto supporto è una red flag medica** finché dolore e sovraccarico non sono esclusi. Mettete sempre al centro l'individuo; una minoranza di persone autistiche non si riconosce nel monotropismo.

Informazioni su questa guida

Con assistenza IA, derivata dalle bozze di ricerca del progetto — la guida **Pratici e sanità lungo l'arco di vita** (Parti 2–5) e la sintesi sul **Monotropismo**. Usa il linguaggio con l'identità per prima („persona autistica”). **Informativa — non è consiglio medico né strumento diagnostico**. Il monotropismo è una teoria potente ma ancora in via di sviluppo; le evidenze sull'età avanzata e sull'alto supporto sono scarse — siate onesti sull'incertezza e adattatela alla singola persona.

Fonti chiave. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2018/2023); Dwyer (2021, 2025); Raymaker et al. (2020, burnout); Mantzalas et al. (2022); Pearson & Rose (2021, masking); Kelly Mahler (2024, interocezione); Klein et al. (2024, invecchiamento); AASPIRE Healthcare Toolkit / AHAT; Autism Society (2025, meltdown/shutdown). Le citazioni complete sono nelle bozze di fonte.